

TRM — IMOBILIZAR + DISTINGUIR CHOQUE

CHOQUE NEUROGÊNICO vs CHOQUE MEDULAR vs HEMORRÁGICO

Aspecto	Choque neurogênico	Choque hemorrágico
Mecanismo	Perda do tônus simpático (lesão cervical/torácica alta)	Perda de volume (sangramento)
Pressão	Hipotensão	Hipotensão
Frequência cardíaca	BRADICARDIA (paradoxal)	Taquicardia
Pele	Quente e seca (vasodilatação)	Fria e pegajosa
Tratamento	Volume + VASOPRESSOR (noradrenalina), atropina se bradicardia	Controle do sangramento + reposição
Choque medular	Termo neurológico: arreflexia/flacidez transitória pós-trauma (não é hemodinâmico)	—

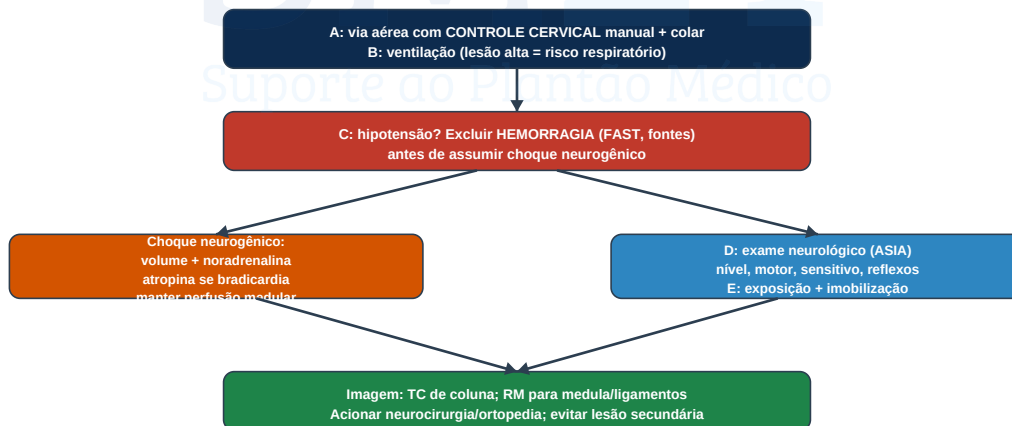
REGRA DE OURO NO TRAUMA

HIPOTENSÃO NO TRAUMA É HEMORRÁGICA ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO

- Mesmo com suspeita de lesão medular, EXCLUIR hemorragia primeiro (FAST, exame, fontes de sangramento) — o choque hemorrágico mata mais rápido
- Choque neurogênico é diagnóstico de exclusão: hipotensão + bradicardia + pele quente, em lesão cervical/torácica alta
- Imobilização da coluna (colar cervical + prancha/maca a vácuo) desde o atendimento pré-hospitalar
- Manter a PA adequada para perfundir a medula lesada (evitar a lesão secundária por hipotensão e hipóxia)
- Corticoide (metilprednisolona) NÃO é recomendado de rotina no TRM (mais risco que benefício)
- Atenção à lesão cervical alta (C3-C5): risco de insuficiência respiratória (nervo frênico)

ATENDIMENTO INICIAL (ABCDE) NO TRM

TRM — VIA AÉREA COM CONTROLE CERVICAL



SÍNDROMES MEDULARES E NÍVEIS

Síndrome/Nível	Características
Lesão completa	Ausência de função motora e sensitiva abaixo do nível (pior prognóstico)
Cordão anterior	Perda motora e de dor/temperatura; propriocepção preservada
Centromedular	Fraqueza maior em membros superiores que inferiores (idoso, hiperextensão)
Brown-Sequard	Hemissecção: motor/propriocepção ipsilateral, dor/temperatura contralateral
C3-C5	Risco de insuficiência respiratória (frênico) — vigiar ventilação
Acima de T6	Risco de choque neurogênico e, depois, disreflexia autonômica

CUIDADOS E COMPLICAÇÕES

Evitar a Lesão Secundária

- Manter PA média adequada (perfusão medular) e oxigenação
- Evitar hipotensão e hipóxia (agravam a lesão)
- Imobilização adequada até excluir lesão instável
- Vigiar a ventilação nas lesões cervicais altas
- Sondagem vesical (retenção/bexiga neurogênica)
- Prevenir hipotermia, úlcera de pressão e TVP

Pontos Importantes

- Corticoide de rotina NÃO é recomendado no TRM
- Choque medular (arreflexia) é fenômeno neurológico transitório, distinto do choque neurogênico (hemodinâmico)
- Priapismo e flacidez podem indicar lesão medular
- Disreflexia autonômica: complicação tardia em lesões altas (HAS paroxística)
- Documentar o exame neurológico (escala ASIA) na admissão
- Reabilitação precoce melhora desfechos

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Imobilização da coluna desde o pré-hospitalar (colar + prancha/maca a vácuo)
- ☐ ABCDE com controle cervical; vigiar a ventilação nas lesões cervicais altas
- ☐ Hipotensão no trauma: excluir hemorragia ANTES de assumir choque neurogênico
- ☐ Choque neurogênico (hipotensão + bradicardia + pele quente): volume + noradrenalina (+ atropina se bradicardia)
- ☐ Manter perfusão e oxigenação para evitar a lesão secundária; corticoide não é rotina
- ☐ Exame neurológico (ASIA) + TC/RM de coluna; acionar neurocirurgia/ortopedia e cuidados de suporte

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Vítima de trauma cervical com hipotensão e BRADICARDIA, pele quente e seca, após exclusão de sangramento. Qual o diagnóstico e o tratamento?

- A) Choque hemorrágico — reposição volêmica isolada
- B) Choque neurogênico — volume + vasopressor (noradrenalina) e atropina se bradicardia
- C) Choque séptico — antibiótico
- D) Choque cardiogênico — dobutamina
- E) Tamponamento cardíaco — pericardiocentese

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Diante de hipotensão em um politraumatizado, mesmo com suspeita de lesão medular, qual deve ser a primeira preocupação?

- A) Assumir choque neurogênico e iniciar vasopressor
- B) Excluir hemorragia (choque hemorrágico é a causa mais comum e mais letal)
- C) Administrar corticoide
- D) Aguardar a tomografia
- E) Iniciar antibiótico

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Sobre o corticoide (metilprednisolona) no trauma raquimedular, qual afirmação é correta?

- A) Deve ser administrado em altas doses para todos
- B) NÃO é recomendado de rotina (mais risco que benefício)
- C) É o principal tratamento do TRM
- D) Reverte completamente a lesão medular
- E) Substitui a imobilização

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual lesão medular tem MAIOR risco de insuficiência respiratória por comprometimento do nervo frênico?

- A) Lesão lombar baixa
- B) Lesão cervical alta (C3-C5)
- C) Lesão sacral
- D) Lesão torácica baixa
- E) Lesão de cauda equina

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Idoso com hiperextensão cervical evolui com fraqueza maior nos membros superiores que nos inferiores. Qual síndrome medular?

- A) Síndrome do cordão anterior
- B) Síndrome centromedular
- C) Síndrome de Brown-Sequard
- D) Lesão completa
- E) Síndrome da cauda equina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hipotensão + bradicardia + pele quente e seca, após excluir sangramento, caracteriza o choque neurogênico (perda do tônus simpático em lesão cervical/torácica alta). O tratamento é volume + vasopressor (noradrenalina), com atropina se bradicardia significativa, mantendo a perfusão medular.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No politraumatizado, a hipotensão é hemorrágica até prova em contrário. Mesmo com suspeita de lesão medular, deve-se excluir o sangramento primeiro (FAST, fontes), pois o choque hemorrágico é a causa mais comum e mais rapidamente letal.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O corticoide (metilprednisolona) NÃO é recomendado de rotina no TRM, pois os estudos mostraram mais riscos (infecção, complicações) do que benefício neurológico consistente. O foco é a imobilização e a prevenção da lesão secundária.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

As lesões cervicais altas (C3-C5) comprometem a inervação do diafragma (nervo frênico, raízes C3-C5), com alto risco de insuficiência respiratória — exigindo vigilância da ventilação e, muitas vezes, suporte ventilatório.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A síndrome centromedular é típica de idoso com hiperextensão cervical (espondilose prévia): cursa com fraqueza desproporcionalmente maior nos membros superiores em relação aos inferiores, com graus variáveis de disfunção sensitiva e esfinteriana.

SM24
Suporte ao Plantão Médico